

Tutti attorno a un genitore autistico

La guida cumulativa per l'intera équipe attorno a un adulto autistico che è (o sta per diventare) genitore — i suoi genitori/famiglia, personale scolastico, responsabili di attività, medici e ostetriche, assistenti/doule, colleghi/datori di lavoro e amici. *Una scheda di riferimento estesa; abbinatela alle guide rapide per singolo interlocutore.*

L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione di un genitore si chiude in pochi „tunnel” profondi e intensi. Fare il genitore è incessante, ad alto canale e imprevedibile — proprio le condizioni che un sistema monotropico trova più difficili — per cui i genitori autistici portano un **alto rischio di burnout** e spesso ignorano i propri bisogni. Ma molti sono **caregiver eccellenti e profondamente attenti** entro i propri interessi e ritmi, e la valutazione del figlio spesso porta alla luce *i loro* tratti. Qualsiasi sia il vostro ruolo, le leve sono le stesse: seguite le loro routine, abbassate il carico, siate prevedibili e concreti e state attenti al burnout che sottovaluteranno. Un'équipe coordinata e accogliente protegge il genitore e la famiglia.

Cosa aiuta in ogni contesto

- **Seguite le loro routine e la loro guida** — la coerenza tra persone e contesti abbassa il carico; non disfatte mai del loro sistema „a modo vostro”.
- **Siate prevedibili e concreti** — stessa persona, stesso piano, preavviso; l'aiuto specifico e pratico batte i consigli.
- **Comunicate alla lettera e per iscritto** dove aiuta; concedete tempo di elaborazione e scelta.
- **Riducete il carico sensoriale e sociale** — più quieto, più calmo, meno sorprese e richieste sociali forzate.
- **State attenti proattivamente al burnout** — chiedete di dolore, esaurimento e alimentazione; lo sottovaluteranno.
- **Protegete i loro interessi e il tempo di recupero** come risorse di benessere, non come vizio.
- **Mantenete l'équipe coordinata e coerente** — condividete un semplice profilo delle routine, dei bisogni sensoriali e dei segnali precoci di allarme del genitore tra famiglia, clinica, nido e lavoro, in modo che l'aiuto si senta unito anziché un altro insieme di richieste.

Cosa evitare in ogni contesto

- Visite a sorpresa, cambi improvvisi o intervenire a fare il genitore/decidere *per* loro.
- Interpretare il sovraccarico o lo shutdown come „non si lega” o „non ce la fa”.
- Aggiungere richieste sociali, sensoriali o di giudizio a un genitore già svuotato.
- Equiparare una superficie „che ce la fa” all'essere „a posto”.

Note rapide per ciascuno attorno al genitore

I suoi genitori e la famiglia allargata

Seguite la loro guida su routine e poppate; offrite aiuto concreto (un pasto, un'ora di pausa, una spesa); tenetevi prevedibili e avvisate prima delle visite. Credetegli se sono autistici o in burnout e prendetevi cura dell'intera famiglia.

Personale scolastico (la scuola del figlio)

Usate di default la comunicazione scritta; siate prevedibili; prendete sul serio la loro competenza sul figlio; tenete un linguaggio letterale. Riconoscete il carico doppio — un bambino neurodivergente e un genitore autistico — e segnalate il supporto.

Responsabili di attività e baby-parking

Condividete il piano in anticipo; riducete il carico sensoriale; offrite modi a bassa pressione per partecipare. Tenete la partecipazione flessibile — un genitore che può entrare e uscire senza giudizio resta connesso.

Medici, ostetriche e puericultrici

Offrite l'**AHAT dell'AASPIRE** e opzioni a prima lo scritto; rendete la cura perinatale prevedibile e calma; cercate proattivamente il burnout e la malattia mentale perinatale. Chiedete delle differenze lifelong, non solo dell'umore attuale.

Assistenti e doule

Seguite le loro routine; siate prevedibili; offrite aiuto concreto e proteggete il tempo di recupero. Chiedete proattivamente di dolore, esaurimento e alimentazione; trasmettete i segnali di crisi.

Colleghi e datori di lavoro

Offrite vera flessibilità; comunicate per iscritto; prendete permessi e adattamenti alla lettera; normalizzate i confini. State attenti al burnout e segnalate medicina del lavoro/assistenza ai dipendenti.

Amici e altri genitori

Offrite aiuto concreto, non „fammi sapere”; tenetelo a bassa pressione e senza sensi di colpa; lasciate la porta aperta. Se sembrano sopraffatti o senza speranza, segnalate con tatto il supporto.

Quando chiedere altro supporto

State attenti al **burnout autistico** e alla malattia mentale perinatale (le due si sovrappongono e necessitano entrambe di cure specifiche). Affrontate ADHD, ansia, disturbi del sonno e gastrointestinali co-occorrenti. Segnalate il **supporto tra pari di genitori autistici** e l'aiuto pratico. Se in casa c'è un bambino neurodivergente, coordinatevi con i servizi pediatrici e riconoscete il carico cumulativo.

Se il genitore è una madre

Le madri autistiche sono spesso mal-diagnosticate (ansia/depressione perinatale) e mascherano intensamente, anche con famiglia, clinici e personale scolastico. Chiedete delle differenze sociali/sensoriali lifelong in ogni contesto, non solo dell'umore attuale — una superficie „che ce la fa” può nascondere un vero sovraccarico.

Informazioni su questa guida

*Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — la guida per la **famiglia** (Parti 4 e 7), la guida **Pratici e sanità lungo l'arco di vita** (Parte 3.4) e la sintesi sul **Monotropismo**. Usa il linguaggio con l'identità per prima. **Informativa — non è consiglio medico né strumento diagnostico**. Adattatela alla singola persona.*

Fonti chiave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020, burnout); Pearson & Rose (2021, masking); Kelly Mahler (2024, interocezione); ASAN. Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.